جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : امال محمد مصطفي الحويجي
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** حلوان **العنوان :** قريه سقاره
رقم البطاقة : 26402272102243 **رقم التليفون :** 01011069722 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 27-02-1964 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: امال محمد مصطفي الحويحي
National ID: 26402272102243

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



سيستم

كاسيا

+

غاسيل تدعيم



National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

02/03/2026

MDT FORM

Name:	Amal Mohamed Mostafa Elhewage	MRN:	6277
Age:	62 Y	ID:	26402272102243
Menopausal Sta	post	Phone:	01011069722
NRS SCORE:		Marital Status:	M
BMI:	25	Family History:	
CO Morbidity:	DM HTN	Reason Of MDT:	post op.

Clinical Data:

BX: IDC

ER: 7/8 PR: 7/8 HER2: + KI67: 12

Sonomammography:
Rt breast cancer recieved NACT with good radiological response

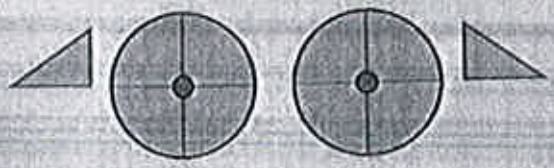
Mets Workup:

History:
post WLE +SLNBx = residual viable IDC G2 - surgical margins free - SLNB=

Recommendations:
consider adj. ttt

MDT Outcome & Plan
ypT2 ypN0, For Adjuvant KAdcyla X 12 Cycle, PORT, Adj femara x 5 years

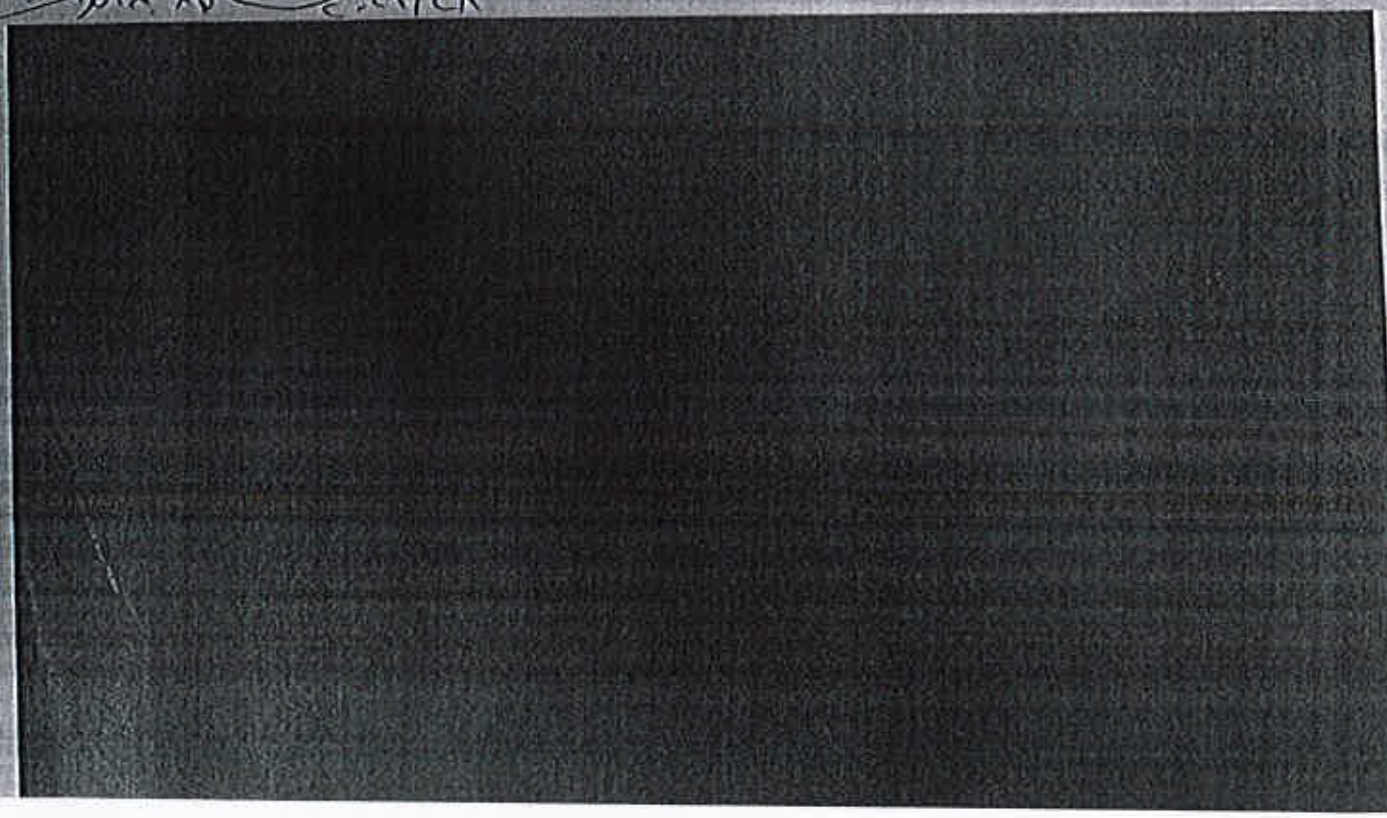
R L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric



MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: امال محمد مصطفي الحويحي **MR. :** 6277	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient has a diagnosis of post-menopausal breast cancer, clinical stage T2 N1, hormone receptor positive (ER 7/8, PR 7/8) and HER2 3+. Neoadjuvant chemotherapy with the TCHP regimen was completed on 13 January 2026, followed by breast-conserving surgery and postoperative radiotherapy. The case was discussed at multidisciplinary tumor board (MDT) for consideration of adjuvant trastuzumab-emtansine (Kadcyla) and placement of a port for ongoing therapy.

The MDT on 2 March 2026 recommended adjuvant Kadcyla for 12 cycles, placement of a port, and initiation of an aromatase inhibitor (Femara) for five years. The patient received cycle 1 of Kadcyla today and cycle 2 was arranged to be obtained from the pharmacy. The patient has completed one cycle of Kadcyla and is scheduled to receive cycle 2.

Laboratory studies were within acceptable limits; an echocardiogram was still pending. The patient was scheduled to receive cycle 2 of Kadcyla together with continued Femara and supportive care.

The patient was scheduled for cycle 3 of Kadcyla with ongoing Femara and supportive care; an echocardiogram remained pending.

The patient was scheduled for cycle 4 of Kadcyla with continued Femara and supportive care. An echocardiogram performed in June 2026 showed an ejection fraction of 66 %. Thyroid ultrasound in June 2026 demonstrated bilateral thyroid nodules classified as TIRADS 4, and thyroid laboratory studies were ordered for further evaluation.

The patient continued on cycle 4 of Kadcyla after laboratory review and had completed the prescribed radiotherapy course of 40 Gy in 15 fractions with an additional boost in June 2026. The patient has completed four cycles of Kadcyla to date.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / امال محمد مصطفى	Request No.	: 13004454
Patient No.	: 26402272102243	Request Date	: 13/01/2026
Path No.	: 94/26	Verification Date	: 18/01/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 61 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, Post-NACT.
Nature of specimen: Right breast wide local excision & Sentinel lymph nodes biopsy.

Gross Examination:
* Right breast wide local excision specimen measured 6x5x3 cm, with covering skin ellipse measured 2.5x1 cm.
* Serialling showed a wire guided clip inserted tumor bed site measured 2.5x1x1 cm, located 0.5 cm from the least medial margin.
* Sentinel lymph nodes: Fibrofatty tissue piece measured 6x4x1 cm, entangling 8 lymph nodes (Only 4 submitted for frozen), the largest measured 1x1x0.5 cm.
* 9 Blocks:
1- Medial margin., 2- Lateral margin., 3- Superior margin., 4- Inferior margin., 5- Deep margin., 6- SLNs., 7:9- T.B.S.
- Gross was done by; Dr. Heba El-Shafeey.

** Frozen (Intra-operative) results:
- Free surgical margins.
- SLNs: Four free sentinel lymph nodes (0/4) (Eight lymph nodes were detected, but only 4 submitted for frozen).

Microscopic Examination:
* Histological type: Residual viable invasive duct carcinoma (Actual tumor size 2.5x1 cm) (Cellularity 25%).
* Grade 2 (differentiation 2, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
* Ductal carcinoma in situ: 1% Low grade ductal carcinoma in situ (Solid pattern).
* Angioinvasion: Absent.
* Perineural invasion: Absent.
* Surgical margins: Free.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL EGYPTE

Patient Name	: الأستاذه / امال محمد مصطفى	Request No.	: 13004454
Patient No.	: 26402272102243	Request Date	: 13/01/2026
Path No.	: 94/26	Verification Date	: 18/01/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 61 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

* Sentinel lymph nodes: Eight lymph nodes free of metastatic deposits, SLNs (0/8).
* Histologic response to therapy: Pathological partial response to therapy.

Diagnosis:
Right breast cancer (Post-NACT), Right breast wide local excision & Sentinel lymph nodes biopsy:
- Residual viable invasive duct carcinoma, Grade 2 (Cellularity 25%) (Actual tumor size 2.5x1 cm).
- Ductal carcinoma in situ: 1% Low grade ductal carcinoma in situ (Solid pattern).
- Surgical margins: Free.
- Sentinel lymph nodes: Eight lymph nodes free of metastatic deposits, LNs (0/8).
• Stage: ypT2, ypN0 (sln).
• RCB: 1.765, RCB class-II.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.
Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Amaal Mohamed Moustafa Alhwihi	Date : 23/01/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 61 Year(s)
Medical ID: 26402272102243	Pat. ID: 97140

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

Right breast palpable lump.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Right breast shows LIQ spiculated irregular mass lesion, of high density.
- Complementary ultrasound revealed
- **Right breast:**
- right breast irregular spiculated hypoechoic mass lesion, with subtle vascularity detected within on color Doppler, seen at 5o'clock position 1 cm from the nipple, 0.4 cm from the overlying skin, measuring 2.7x2 cm, consistent to the palpable lump.
- Single Pathological right axillary lymph node shwoi9ng effaced fatty hilum and focal cortical thickening reaching 5mm
- Free right supra and infraclavicular regions.
- **Left breast:**
- No suspicious solid or cystic mass lesions.
- Nonspecific left axillary LN.

Opinion:

- Right breast LIQ malignant looking mass lesion (BIRADS 5) for histopathological correlation associated with single Pathological right axillary LN.
- Benign findings left breast (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. basma mohmaed

23/01/2025 2:24 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient Name: Amaal Mohamed Moustafa Alhwihi	Date : 04/03/2025
Exam : C.T CHEST	Age : 61 Year(s)
Medical ID: 536/2025	Pat. ID: 97140

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

- Reported case of breast cancer.

I Chest:

- Right breast irregular mass lesion is seen measuring about 3.2x 2.5 cm.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of ground glass attenuation, consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross enlargement.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is enlarged showing multiple hypodense rounded focal lesions seen bilibar, the largets seen at segment III meauring about 1.3 cm in diameter.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal non contrast CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys(aprt from left renal stone measures about 1,5, 1100 HU) and suprarenals glands.
- Averagely filled urinary bladder showing no sizable diverticular outpouching.
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.
- No ascites.
- D8 vertebral body subtle lucent area with right iliac sclerotic foci are seen.

Opinion:

- Reported case of breast cancer revealed:

- **No CT evidence of sizable pulmonary deposits.**
- **Bilobar hepatic focal leisons for further assessment.**
- **D8 vertebral body subtle lucent area with right iliac sclerotic foci for bone scan.**
- **Left renal stone**

Prof. Menna Tallah Hanafy, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]